

Capgras Sendromu

Capgras Sendromu, kişinin kendisi için önemli ve tanıdık bir insanın - çoğunlukla eşi, aile üyesi veya yakın bir yakınının- aslında gerçek kişi olmadığına ve onun yerine tıpatıp benzeyen bir sahtekarın geçtiğine inanmasıyla karakterize edilen nadir bir sanrısız yanılsama kimliklendirme sendromudur. Hasta karşısındaki kişinin fiziksel olarak aynı görüldüğünü kabul etse bile onun gerçek yakını olduğuna inanmaz. Bu nedenle Capgras Sendromu halk arasında “ikiz sanrısı” olarak da ifade edilmektedir. Sendrom ilk kez 1923 yılında Fransız psikiyatristler Joseph Capgras ve Jean Reboul-Lachaux tarafından tanımlanmış ve başlangıçta *l'illusion des sosies* (“benzerlerin/ikizlerin yanılsaması”) olarak adlandırılmıştır.

Capgras Sendromunun temel belirtisi, tanıdık bir kişinin yerine başka birinin geçtiğine ilişkin sanrısız inançtır. Hasta eşinin veya başka bir yakınının yüzünü ve görünüşünü tanıyabilir; ancak onun gerçek kişi olduğuna ilişkin duygusal ve öznel aşinalık hissini kaybedebilir. Örneğin, “Bu kişi eşime çok benziyor fakat eşim değil, onun yerine geçen bir sahtekar” şeklinde kesin bir inanca sahip olabilir. Bu düşünce sıradan bir şüphe veya kararsızlık değildir; hasta çoğunlukla bu inanca güçlü biçimde bağlıdır.

Yanılsama kimliklendirme; kaygı, huzursuzluk, korku, kuşku, ajitasyon ve öfkeye neden olabilir. Hasta gerçek yakınının kendisini kandırdığına veya birilerinin onun yerini değiştirdiğine inanabildiğinden, çevresindeki kişilerin açıklamalarını kabul etmekte zorlanabilir. Sanrı ilerledikçe “gerçek kişinin” kim olduğunu kanıtlamaya yönelik davranışlar gösterebilir ve karşısındaki kişinin gerçekten eşi veya yakını olduğunu kanıtlamasını isteyebilir. Bu durum kişilerarası ilişkilerin bozulmasına ve aile içinde ciddi çatışmalara yol açabilir.

Hasta yanılsama kimliklendirdiği kişiyi bir tehdit olarak algıladığında saldırgan veya şiddet içeren davranışlar ortaya çıkabilir. Bununla birlikte, Capgras Sendromu olan her hastanın şiddet davranışı göstermediği ve şiddet içermeyen vakaların da önemli bir bölüm oluşturduğu belirtilmektedir. Bazı olgularda yanılsama kimliklendirme yalnızca insanlar için değil, hayvanlar veya cansız nesneler için de görülebilir.

Belirtilerin şiddeti ve seyri altta yatan hastalığa göre değişebilir. 2026 yılında yayımlanan geniş bir kohort çalışmasında, Capgras belirtilerinin özellikle akşam veya gece saatlerinde kötüleştiği ve bunun olumsuz duygusal durumlarla ilişkili olabileceği bildirilmiştir.

Capgras Sendromunun tek bir nedeni yoktur. Güncel bilgiler, sendromun özellikle yüzleri tanıma, duygusal tepki oluşturma, hafıza, öz-izleme ve gerçekliği değerlendirme gibi süreçlerin bozulmasıyla ilişkili olduğunu göstermektedir.

Öne çıkan açıklamalardan biri, kişinin tanıdığı yüzü görsel olarak tanıyabilmesine rağmen, o kişiye ilişkin normal duygusal aşinalık hissini oluşmamasıdır. Normalde tanıdığımız bir insanın yüzünü gördüğümüzde yalnızca kim olduğunu belirlemeyiz; aynı zamanda o kişiye yönelik bir tanıdıklık ve duygusal yakınlık hissederiz. Capgras Sendromunda yüz tanıma ile bu duygusal tepki arasındaki bağlantının bozulabileceği düşünülmektedir. Böylece hasta tanıdığı kişinin görünüşünü fark eder ancak beklenen aşinalık hissini yaşayamaz ve bu çelişkiyi “gerçek kişinin yerine bir sahtekar geçti” şeklinde yorumlayabilir.

Bu süreçte özellikle sağ frontal bölgeler, temporal bölgeler ve limbik sistemin rol oynadığı düşünülmektedir. Daha yeni nörogörüntüleme bulguları, Capgras Sendromunda özellikle sağ frontal disfonksiyonla birlikte yaygın bilateral kortikal tutulum görülebileceğini göstermektedir. Bu nedenle sendrom yalnızca bir “yüzü tanıyamama” problemi olarak değil; yüz tanıma, duygular, hafıza, gerçeklik değerlendirmesi ve kişinin kendi düşüncelerini kontrol etme süreçlerinin birlikte bozulduğu daha karmaşık bir nöropsikiyatrik durum olarak değerlendirilmektedir.

Capgras Sendromu tek başına ortaya çıkabileceği gibi çeşitli psikiyatrik ve nörolojik hastalıklarla birlikte görülebilir. Kaynaklarda

özellikle Lewy cisimcikli demans, Alzheimer hastalığı, şizofreni, şizoaffektif bozukluk, bipolar bozukluk, epilepsi, Parkinson hastalığı, serebrovasküler hastalıklar ve çeşitli beyin hasarları ile ilişkili olduğu bildirilmektedir. 2026 yılında yayımlanan geniş kohort çalışmasında incelenen 204 hastanın %69’unda nörodejeneratif hastalık bulunduğu ve en sık görülen tanının Lewy cisimcikli demans (%58) olduğu bildirilmiştir. Psikotik bozukluklar ise vakaların %9’unu oluşturmuştur. Bu bulgular, Capgras Sendromunun özellikle nörodejeneratif hastalıklar bağlamında önemli bir klinik belirti olabileceğini göstermektedir.

Capgras Sendromunun tanısı öncelikle klinik değerlendirmeye dayanır. Bununla birlikte, sendroma yol açabilecek nörolojik veya tıbbi durumların belirlenmesi amacıyla gerekli durumlarda laboratuvar incelemeleri ve beyin görüntülemeleri yapılabilir. Özellikle demans, beyin lezyonları, nörodejeneratif hastalıklar ve diğer organik nedenlerin araştırılması önemlidir.

Tedavide tek bir standart yöntem bulunmamaktadır. Bunun temel nedeni Capgras Sendromunun farklı hastalıkların sonucunda ortaya çıkabilmesi ve nadir görülmesi nedeniyle tedavi çalışmalarının sınırlı olmasıdır. Genel yaklaşım, altta yatan hastalığın tedavi edilmesi, uygun hastalarda antipsikotik ilaçların kullanılması ve psikoterapötik/psikososyal destek sağlanmasıdır.

Hastanın inancıyla doğrudan çatışmak veya onu zorla ikna etmeye çalışmak yerine, yaşadığı korku ve kaygıyı anlamaya yönelik empatik ve sakin bir iletişim kurulması önerilmektedir. Özellikle aile üyeleri ve bakım verenlerin hastanın yaşadığı durumu anlaması önemlidir. Hastanın “sahtekar” olarak gördüğü kişiyle doğrudan karşı karşıya gelmesi bazı durumlarda kaygı ve ajitasyonu artırabileceğinden, açık, sakin ve güven verici bir iletişim tercih edilmelidir. Kendisine veya başkasına zarar verme riski bulunan hastalarda ise daha yoğun psikiyatrik değerlendirme ve gerektiğinde hastaneye yatırma gündeme gelebilir.

Kısaca Capgras Sendromu, kişinin tanıdığı ve sevdiği birinin gerçek kişi olmadığına ve onun yerine aynı görünen bir sahtekarın geçtiğine inanmasıyla ortaya çıkan nadir bir sanrısız yanlış kimliklendirme sendromudur. Temel sorun yalnızca yüzü tanıyamamak değil; yüz tanıma ile duygusal aşinalık, hafıza ve gerçeklik değerlendirmesi arasındaki bağlantıların bozulmasıdır. Bu nedenle hasta yakınının görünüşünü tanıyabilir ancak ona karşı “bu benim yakını” hissini yaşayamayabilir.

Sendrom; Lewy cisimcikli demans ve Alzheimer hastalığı gibi nörodejeneratif hastalıkların yanı sıra şizofreni ve diğer psikiyatrik veya nörolojik hastalıklarla ilişkili olabilir. Hastada kaygı, kuşku ve ajitasyon görülebilir; bazı vakalarda yanlış tanımlanan kişiye yönelik saldırganlık riski de ortaya çıkabilir. Bu nedenle Capgras Sendromunun erken fark edilmesi, altta yatan nedenin araştırılması ve uygun şekilde yönetilmesi önemlidir.

Kaynaklar:

1) Shah KP, Jain SB, Wadhwa R. Capgras Syndrome. 2023 May 29. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2026 Jan-. PMID: 34033319.

2) Brigo F. Capgras Syndrome in Popular Media: A Cinematic Exploration in Kinds of Kindness (2024). Clin Neuropsychiatry. 2025 Apr;22(2):165-166. doi: 10.36131/cnforitieditore20250207 . PMID: 40401142; PMCID: PMC12090369.

3) Watanabe H, Whitwell JL, Bhaskaran JG, Lowe VJ, Josephs KA. Imposter in the brain: aetiological, clinical and neuroimaging characteristics of Capgras syndrome. Brain. 2026 Apr 7;149(4):1224-1238. doi: 10.1093/brain/awaf378. PMID: 41059767; PMCID: PMC13058470.

Ali Bocakkıta/ Founder,
Wionpav Labs/ Medical Student,
Faculty of Medicine, Selçuk
University